MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 1135/2024/MPO

Assunto: **CC 61202 – Projeto de Apoio as Redes Regionais de Atenção à saúde do Estado de São Paulo - ARAS**

Proponente: **Governo do Estado de São Paulo**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto de Apoio às Redes Regionais de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo oferece uma visão detalhada dos desafios enfrentados pelo setor de saúde no Estado de São Paulo, que é o proponente desta iniciativa. O Estado de São Paulo responde por mais de 32,2% do PIB nacional e ocupa 3% do território do país, com uma população de 44 milhões de habitantes. Uma grande parte dessa população reside em áreas marcadas por desigualdades sociais, incluindo o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba e Itapeva, onde há dificuldades significativas no acesso aos serviços de saúde. Embora o Estado disponha de uma extensa Rede de Serviços, problemas organizacionais comprometem a efetividade de sua cobertura, principalmente devido à falta de integração entre os serviços hospitalares e os demais níveis de assistência, especialmente os relacionados à atenção básica. Esses desafios incluem a fragmentação dos cuidados, dificuldades no acompanhamento de casos crônicos e a inadequação na atuação por conta da ausência de padronização, linhas de cuidado e protocolos de atendimento.

As ações propostas neste Projeto visam melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população usuária do SUS no Estado de São Paulo e incluem: a construção de dois novos hospitais nas Redes Regionais de Atenção à Saúde nº 8 (RRAS 8) e nº 12 (RRAS 12) contendo 499 leitos; melhorias e inovações no parque tecnológico das unidades de saúde estaduais na Região Metropolitana de São Paulo; implantação de novas tecnologias voltadas à Saúde Digital; execução de infraestrutura para tecnologia da informação e modernização dos equipamentos em 15 hospitais da administração direta contemplados neste projeto; modernização e aquisição de servidores, armazenamento de dados, segurança da informação, e a implementação de novas tecnologias, como telemedicina e informatização das unidades, facilitando o acesso a ferramentas de gestão.

O pedido de empréstimo ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é de até US$ 230.000.000,00, com um prazo estipulado de 60 meses para o desembolso e execução das ações propostas.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,404 para a análise técnica e 0,133 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,404/4,000**

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções

propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O "Projeto de Apoio às Redes Regionais de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo - ARAS" está caracterizado de forma clara, oferecendo uma visão abrangente dos desafios atuais enfrentados pelo setor de saúde no Estado de São Paulo, proponente deste pleito. O pedido de empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é de até US$ 230.000.000,00, com uma contrapartida do Estado de São Paulo de aproximadamente US$ 113.000.000,00, provenientes de recursos tributários. O proponente, localizado no sudeste do país, informa que é responsável por mais de 32,2% do PIB e ocupa 3% do território nacional, com uma população de 44 milhões de habitantes (IBGE, 2022). Grande parte dessa população reside em áreas com grandes desigualdades sociais, como o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba e Itapeva, enfrentando barreiras e problemas no acesso aos serviços de saúde. Apesar da extensa Rede de Serviços no Estado, há problemas organizacionais que comprometem sua cobertura, como a falta de integração entre os serviços hospitalares e os demais níveis assistenciais, especialmente relacionado a atenção básica. Esses problemas incluem a fragmentação dos cuidados, dificuldades no acompanhamento de casos crônicos e uma atuação inadequada devido à ausência de padronização, linhas de cuidado e protocolos de atendimentos. Além disso, a estrutura dos serviços é antiga e não está adequadamente adaptada às novas necessidades assistenciais do SUS. O Estado de São Paulo possui diversos municípios com pequenas populações e grandes desigualdades socioeconômicas, enfrentando dificuldades para estruturar uma Rede de Atenção à Saúde (RAS) que atenda plenamente às necessidades de saúde de suas populações, a regionalização surge como a solução para alcançar eficiência dos recursos. A descrição dos problemas está clara e há coerência o propósito do Projeto.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As medidas propostas para a regionalização das redes assistenciais de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), incluem um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento e à melhoria da oferta de serviços essenciais nas regiões mais pobres e vulneráveis do Estado de São Paulo, demonstrando alinhamento com os problemas identificados. Existe uma estreita relação entre as soluções propostas e a resolução dos desafios apresentados.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

De modo geral, o Programa visa melhorar a qualidade das condições de saúde da população do Estado de São Paulo, usuários do SUS, por meio de diversas ações de investimento. A solução proposta inclui a construção de dois novos hospitais nas Redes Regionais de Atenção à Saúde nº 8 (RRAS 8) e nº 12 (RRAS 12); adequações e inovações no parque tecnológico das unidades de saúde estaduais da Região Metropolitana de São Paulo; implantação de novas tecnologias voltadas à Saúde Digital; execução de infraestrutura para tecnologia da informação e modernização dos equipamentos nos 15 hospitais da administração direta contemplados neste Projeto; além da modernização e aquisição de servidores, armazenamento de dados, segurança de dados, e a inserção de novas tecnologias, incluindo telemedicina e informatização das unidades atendidas, facilitando o acesso às ferramentas de gestão. As soluções propostas demonstram coerências com os resultados esperados após o investimento.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O Projeto oferece um detalhamento abrangente das ações planejadas, onde a solução proposta contempla a construção de dois novos hospitais nas Redes Regionais de Atenção à Saúde, a modernização do parque tecnológico das unidades de saúde na Região Metropolitana de São Paulo, e a implementação de novas tecnologias voltadas à Saúde Digital. O projeto também prevê a modernização dos equipamentos em 15 hospitais da administração direta, a atualização dos servidores e a melhoria do

armazenamento e da segurança de dados, além da introdução de tecnologias como telemedicina e informatização das unidades.
O Proponente destaca que, com a atualização das Unidades envolvidas e a renovação de um parque tecnológico obsoleto, espera-se ampliar o acesso a diagnósticos e tratamentos nas regiões mais necessitadas do estado, elevando a qualidade da assistência à saúde para os usuários do SUS. A justificativa para o Projeto foi apresentada de forma satisfatória, com soluções adequadas e bem fundamentadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Programa, em síntese, contribuir para a melhoria das condições de saúde da população do Estado de São Paulo por meio da estratégia de regionalização, com o objetivo de consolidar as Redes de Atenção à Saúde (RAS) e fortalecer a capacidade de gestão do estado. Nota-se estreito alinhamento entre o objetivo geral do projeto e as soluções propostas com o resultado pretendido.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos delineados pelo Proponente envolve diversos aspectos de melhorias para as redes de atenção a saúde, e incluem: 1) Redefinir o perfil assistencial das unidades de saúde no processo de regionalização para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços; 2) Apoiar a elaboração dos Planos Regionais Integrados para fortalecer a rede e a governança regional; 3) Implementar o Plano Diretor de Educação Permanente, valorizando os Centros Formadores e de Qualificação para o SUS; 4) Modernizar equipamentos e infraestrutura com foco em novas tecnologias para a saúde digital; 5) Melhorar a eficiência dos gastos e a qualidade dos serviços assistenciais, integrando os diferentes níveis de atenção e garantindo um acompanhamento mais completo dos pacientes; 6) Fortalecer a gestão populacional de saúde com a análise de grandes bancos de dados, aprimorando indicadores epidemiológicos e o monitoramento de programas; 7) Investir em novas tecnologias, como telemedicina e informatização, para melhorar a gestão e ampliar o acesso aos serviços de saúde; 8) Modernizar a infraestrutura e tecnologia dos hospitais nas RRAS 1 a 6, para melhorar a eficiência e preparar a rede para futuros desastres climáticos; 9) Construir novos hospitais nas RRAS 8 e 12, visando suprir a carência assistencial e agilizar o atendimento, especialmente para condições crônicas. Nota-se alinhamento direto dos objetivos específicos do Projeto em pleito com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

A estrutura elaborada pelo Proponente para implantação e execução do Projeto parece coerente. Os componentes citados no Projeto estão divididos em investimentos voltados à i. apoio aos processos de gestão com ênfase na regionalização da saúde; ii. infraestrutura e atualização do parque tecnológico; iii. inovação digital - saúde digital; iv. gestão do projeto.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos citados no Programa estão alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações fornecidas pelo Proponente sobre a estrutura de distribuição dos recursos, divididos em componentes, subcomponentes e produtos resultantes, estão alinhadas e são coerentes. O Projeto demonstra conformidade com os objetivos estabelecidos, as soluções propostas e os resultados esperados, resultando em informações adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores descritos pelo Proponente estão diretamente relacionados aos resultados esperados. Observa-se os indicadores possuem estreita relação com os objetivos específicos apresentados no Projeto. Destacam-se os indicadores: i. Número de novos leitos SUS instalados nas RRAS 8 e 12; ii. Média mensal de pacientes atendidos nos novos leitos instalados nas RRAS 8 e 12; iii. Número de atendimentos ambulatoriais e hospitalares realizados pela administração direta e autarquias; iv. Média de dias de permanência institucional dos hospitais gerenciados pela adm. Direta e Autarquias; v. Número de Planos Regionais Integrados elaborados; vii. Número de aplicações de tecnologia sustentadas no âmbito da secretaria de estado da saúde.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e possuem as fórmulas de cálculo adequada.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos, estão atreladas as soluções propostas e são passíveis de cálculo. Como exemplo citam-se o indicador "Número de atendimentos ambulatoriais e hospitalares realizado pelas unidades gerenciadas pelas Organizações Sociais da Saúde (OSS)" que se pretende, após a execução do Projeto, ampliar em 18%.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados no Programa são relevantes e compatíveis com os resultados pretendidos.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os prazos para alcançar as metas planejadas, definidas nos indicadores, estão implícitos, presumindo-se que serão atingidos ao longo da implantação do Projeto (previsto para realizar-se ao longo de 05 anos), com a meta final sendo alcançada apenas ao término deste.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

De modo geral, os indicadores citados na Carta-consulta são suficientes e concisos em relação aos resultados e objetivos pretendidos. O Proponente soube apresentar indicadores que abrangem todo o escopo das ações a serem realizadas com o investimento solicitado denotando adequada as informações.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os desembolsos estão planejados para ocorrer ao longo de 5 anos, distribuídos conforme a estrutura de componentes, subcomponentes e produtos definidas pelo proponente. De forma geral, ao longo de deste período, os investimentos estarão voltados principalmente às ações de reformas das unidades assistenciais de saúde e na atualização do parque tecnológico da rede hospitalar relacionada ao Projeto. Verifica-se compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do Projeto.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Percebe-se distribuição adequada dos recursos nos componentes, subcomponentes e produtos elencados pelo Proponente. Dos recursos pleiteados, 80,34% serão destinados ao Componente 1, relacionado à infraestrutura e atualização do parque tecnológico das redes assistenciais envolvidas. O Componente 2, voltado à inovação digital, receberá 13,91% dos recursos. Para o Componente 3, que apoia os processos de gestão, serão alocados 3,91%. Finalmente, o Componente 4, que trata da gestão completa do Projeto, contará com 2,61% dos recursos.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Há certa coerência entre os componentes e a distribuição dos recursos pleiteados.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O cronograma apresentado se demonstra adequado. A alocação de recursos para a implementação do Projeto foi apresentada de forma coerente demonstrando análise cuidadosa da equipe envolvida na preparação da Carta-consulta. Embora os recursos de contrapartida não foram distribuídos no cronograma apresentado, foi informado que o valor previsto, provenientes de recursos do estado de SP (U$ 113.000.000,00) será destinado à construção duas novas unidades hospitalares nos municípios de Birigui (274 leitos) e Itapetininga (225 leitos). As informações fornecidas no cronograma de desembolso são consideradas completas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada justificativa coerente para a escolha do financiador externo ao invés de agências de fomento nacionais. A decisão pelo financiamento externo é fundamentada nos custos financeiros mais baixos e nas condições mais favoráveis de empréstimo, que incluem prazos de carência mais longos, taxas de juros mais competitivas e melhores condições de amortização em comparação aos financiamentos nacionais.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justifica de maneira adequada sua escolha pelo BID, destacando as taxas de juros mais baixas oferecidas, conforme demonstrado no anexo à Carta-consulta. Além disso, o proponente enfatiza a experiência positiva do BID em projetos de saúde no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, como evidenciado pelo exitoso projeto de Fortalecimento da Gestão de Saúde. Informam que o

Estado de São Paulo possui um histórico sólido de relacionamento com o BID, tendo recebido apoio em diversos projetos em várias áreas. O Proponente também destaca seu conhecimento e experiência com as normas de licitação do Banco, o que facilita o relacionamento com a instituição financeira.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

São apresentadas informações detalhadas sobre as condições financeiras do agente definido para a tomada de empréstimo, que são: O agente escolhido, AFD, oferece condições financeiras mais atrativas que incluem:
- Prazo de Carência: 60 meses
- Prazo de Desembolso: 60 meses
- Prazo de Amortização: 180 meses
- Prazo Total do Financiamento: 240 meses
- Taxa de Juros: 1,66% + EURIBOR 6M a.a
- Comissão de compromisso: 0,50% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo
- Comissão de Avaliação: 0,5%

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado pelo Proponente um quadro comparativo contendo 04 agências de fomento externo (NDB, BIRD, CAF), incluindo o BID. Foi acrescentado comparativos de condições financeiras para empréstimos em bancos nacionais incluindo BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

A justificativa apresentada pelo Proponente para a escolha do financiamento externo, assim como a comparação entre as agências internacionais e nacionais, foi elaborada de modo abrangente, revelando-se completa e precisa.

2 - GESTÃO (0,752/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A Matriz de Responsabilidade Institucional, no modelo RACI, foi apresentada em anexo à Carta-consulta e está adequadamente estruturada para a implementação do Projeto. Os órgãos responsáveis pela execução, assim como suas responsabilidades e funções específicas, estão claramente delineados. O arranjo de preparação do Programa contará com uma Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), vinculada à Secretaria Estadual da Saúde (SES/SP), composta por servidores públicos encarregados de conduzir todas as atividades necessárias para a implementação das ações, após a aprovação do pleito.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente destaca sua experiência com as políticas de contratação do agente financeiro selecionado, assim como com as políticas e salvaguardas ambientais. Além disso, enfatiza que as diretrizes e salvaguardas sociais do BID serão rigorosamente aplicadas ao Projeto.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A Unidade de Coordenação do Projeto (UGP) será composta por profissionais altamente experientes nas políticas de aquisições de organismos internacionais financiadores. O Proponente informa que conta com uma equipe técnica própria, composta por especialistas em gestão, saúde, finanças, licitações e outras áreas essenciais para o Projeto. Essa equipe possui um histórico de sucesso na execução de programas financiados por organismos internacionais, como o Programa de Fortalecimento da Gestão na Saúde no estado de São Paulo, realizado entre 2014 e 2021, além de contar com o suporte de serviços de consultoria contratada especificamente para programas financiados.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Foi constatado que há uma equipe experiente disponível para a implementação das ações previstas no Projeto, e as informações fornecidas sobre a estrutura operacional necessária para sua preparação e execução são adequadas. O Proponente apresenta informações detalhadas sobre o funcionamento da Secretaria de Saúde de São Paulo, o alinhamento estruturado junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) e suas responsabilidades, que incluem: manter a rede assistencial própria do Governo do Estado; Gerir, planejar e regular a rede assistencial vinculada ao SUS; manter os órgãos estaduais de apoio às ações da Secretaria de Saúde; realizar, coordenar e planejar as ações de saúde coletiva no Estado; desenvolver ações de supervisão, capacitação, acompanhamento, avaliação e apoio aos sistemas de saúde municipais. As informações apresentadas são abrangentes, completas e atendem o contexto necessário para pontuação máxima no requisito

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,088/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As medidas para operacionalizar e sustentar as ações decorrentes do Projeto, incluindo a garantia da sustentabilidade financeira após a conclusão das iniciativas, serão conduzidas pelas Secretaria de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, que serão as responsáveis pela continuidade e pelo aporte dos recursos necessários.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não há informações explícitas sobre a previsão de instrumentos ou medidas que assegurem a sustentabilidade financeira das ações decorrentes do Projeto, embora infira-se que o custeio continuará a ser sustentado pelos recursos provenientes do SUS.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não há informações claras sobre a previsão dos custos de manutenção após a conclusão do Projeto.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente não fornece informações detalhadas sobre as medidas de operacionalização e manutenção das ações após a implementação do Projeto nas Redes de Apoio especificadas. Também não foram apresentadas informações detalhadas sobre o custeio da manutenção das ações financiadas pelos

investimentos pleiteados. As informações fornecidas estão imprecisas em relação a esse requisito.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Conforme destacado pelo Proponente, o Projeto está alinhado com o Plano Plurianual (PPA 2024-2027), especialmente no que diz respeito ao atendimento integrado e regionalizado no SUS no Estado de São Paulo. O PPA prevê a criação de uma Rede Integrada de Serviços que permita um acesso mais ágil dos usuários dentro de sua região. O plano enfatiza a necessidade de desenvolver e implantar políticas públicas robustas, oferecendo apoio técnico e financeiro aos municípios do estado, com o objetivo de fortalecer a governança da rede e ampliar os serviços para toda a população.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente cita que as ações propostas no Programa estão alinhadas com o Plano Estadual de Saúde, com o Plano Plurianual (PPA), com o Plano Diretor de Regionalização (PDR) e com as Políticas Públicas do Ministério da Saúde.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

De maneira geral, o Projeto está alinhado com o Plano Plurianual (PPA), refletindo a coerência com as estratégias e ações adotadas pelo Estado de São Paulo para promover melhorias na saúde das populações das regiões contempladas pelo Projeto. As informações apresentadas na Carta-consulta são aceitáveis.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,954/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Existem informações relevantes sobre o estágio das ações prévias necessárias para a execução do Projeto, que se baseiam no levantamento realizado pelo Programa de Fortalecimento de Gestão em Saúde no Estado de São Paulo, de 2014 a 2021. Esse levantamento destacou a necessidade urgente de investimentos em tecnologia para inovar nas práticas gerenciais e assistenciais no SUS. Em 2023 iniciou-se um processo para a estruturação e qualificação de estratégias de gestão com foco no processo de Regionalização da Saúde no Estado de São Paulo.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas pelo Proponente são coerentes e nota-se claramente as necessidades relacionadas às ações previstas para a execução do Projeto.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O Proponente informa ter realizado rodadas de oficinas em todas as regiões do Estado de

São Paulo em que se verificou a necessidade de ações imediatas para qualificação e a implementação de ações visando fortalecer a governança e a resolutividade da gestão do SUS, além de investimentos em tecnologia e adequação da infraestrutura nas regiões mais carentes de recursos. As informações apresentadas na Carta-consulta são aceitáveis.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,282/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0.

Foi informado pelo Proponente que o arcabouço legal para a condução do Projeto está em implementação. Não há detalhamento relacionado aos atos legais e institucionais necessários, seus riscos e ações mitigadoras.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado um detalhamento sobre as contratações, incluindo seus riscos e as ações mitigadoras propostas. As principais contratações estão associadas aos produtos listados nos componentes do Projeto e incluirão a aquisição de bens, consultorias e serviços. O Proponente identificou que os principais riscos estão relacionados a possíveis atrasos na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, como planos de aquisição, termos de referência, projetos executivos, estimativas de custos e editais. Para mitigar esses riscos, o Proponente planeja utilizar a experiência dos gestores do programa com contratos de financiamento internacional e contará com apoio especializado em aquisições. Além disso, serão implementadas medidas de monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, incluindo reuniões periódicas para avaliar o desempenho dos contratos, identificar possíveis problemas e elaborar planos de ação para garantir o cumprimento deles.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente informa que o Projeto não envolve nenhuma ação de desapropriação ou reassentamento, uma vez que os terrenos previstos para a construção dos hospitais pertencem ao Estado de São Paulo e já estão disponíveis.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente informa que a implementação das ações do Programa passará por acompanhamento permanente pelos conselhos estaduais e municipais de políticas públicas e garantias de direitos, implicando gestores públicos, técnicos da área, sociedade civil e beneficiários diretos. Para o risco de privilégio indevido na seleção de beneficiários, serão construídas ferramentas de mitigação que trarão com informações transparentes e objetivas, focando no público a ser beneficiado, conforme critérios técnicos legalmente estabelecidos. O Proponente demonstra compromisso com a legislação vigente e a política de sustentabilidade do BID, reconhecendo que empreendimentos de infraestrutura, como os novos hospitais do Projeto ARAS, podem causar impactos ambientais. No entanto, o Projeto visa promover a qualidade de vida, incorporando princípios de sustentabilidade e preservação ambiental. Será adotado um sistema alinhado aos padrões do Marco de Política Ambiental e Social (MPAS) do BID, para mitigar riscos e melhorar o desempenho ambiental e social ao longo do ciclo de vida do Projeto.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações fornecidas no Projeto estão contextualizadas com as ações planejadas.

Englobam a identificação dos principais riscos em cada área e as medidas para mitigá-los. No entanto, o Proponente deixou de apresentar detalhamento aprofundado quanto aos atos legais e institucionais necessários, seus riscos e ações mitigadoras. Contudo, consideram-se as informações adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente afirma que possui experiência com agências financeiras para captação de crédito o que pôde ser confirmado ao consultar o sistema SIGS da SEAID e verificar os diversos contratos em execução.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O cálculo a seguir foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foi considerado na Carteira de contratos assinados do Proponente apenas aqueles com datas superiores a 10 anos, sendo feito a exclusão das operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex - 12/09/2024 - sendo o período considerado de 12/09/2014 a 12/09/2023.
Os Programas considerados, obtidos do Relatório Projetos Avaliados pela Média (retirados do SIGS) foram: 1) Projeto Aquisição de Trens para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - BID (Nota 73,49); 2) Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo - Fase 2 - Fonplata (Nota 50,24); 3) Programa de Apoio à Gestão de Integração dos Fiscos no Brasil PROFISCO II SP - BID (Nota 61,45); 4) São Paulo Ma Digital - BID (Nota 100); 5) Extensão da Linha 2 Verde - Aquisição Material Rodante - BID (Nota 100); 6) Empreendimento Rede Metroferroviaria de São Paulo - Linha 17 - Ouro - Trecho 1 Estacão Jardim Aeroporto Congonhas a Estacão Morumbi CPTM Sistema Monotrilho - CAF (Nota 35,8); 7) Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu Guaçu e Barragens Pedreira e Duas Pontes - CAF (Nota 20); 8)Programa de Logística e Transportes do Estado de São Paulo - SANTANDER (Nota 50). Média do desempenho da carteira: 61,37. Pontuação: 3 – Regular (média entre 50 a 70%). *Programas com dados no relatório cuja situação aponta "dados insuficientes" foram desconsiderados.

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,133/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto está diretamente voltado às melhorias na prestação de serviços públicos, relacionados à saúde e envolve melhorias na gestão das redes assistenciais vinculadas à SES/SP. No entanto, a pontuação será considerada apenas para o item correspondente às melhorias das condições de educação e saúde.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto tem ações diretamente voltadas às melhorias na área da saúde para o Estado de São Paulo. Estas incluem investimentos para construção de dois novos hospitais nas Redes Regionais de Atenção à Saúde nº 8 (RRAS 8) e nº 12 (RRAS 12); adequações e inovações no parque tecnológico das unidades de saúde estaduais da Região Metropolitana de São Paulo; implantação de novas tecnologias voltadas à Saúde Digital; execução de infraestrutura para tecnologia da informação e modernização dos equipamentos nos 15 hospitais da administração direta contemplados neste Projeto; modernização e aquisição de servidores, armazenamento de dados, segurança de dados, e a inserção de novas tecnologias, incluindo telemedicina e informatização das unidades atendidas. Tais medidas, justificam a pontuação neste

requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações diretas que justifiquem pontuação neste requisito, ainda que tenha diversas ações voltadas às melhorias e investimentos em tecnologia, telemedicina, modernização nas redes hospitalares relacionadas ao pleito em tela.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

CONCLUSÃO

Ao abordar questões críticas, como a fragmentação dos cuidados e a falta de integração entre os níveis de assistência em determinadas regiões do Estado de São Paulo, o Projeto ARAS SP propõe ações que visam à modernização da infraestrutura e à implementação de novas tecnologias, tornando a rede de saúde mais eficiente e acessível. Através da análise técnica realizada, conclui-se que o Projeto apresenta informações sólidas e demonstra viabilidade de alcançar os resultados esperados no período de investimento planejado, com potencial para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população usuária do SUS. O financiamento solicitado é essencial para viabilizar essas transformações, que prometem fortalecer a rede de saúde estadual e aprimorar as condições de atendimento à população.

A gestão do Programa está bem estruturada, com responsabilidades claramente definidas para sua implementação e o Proponente possui ampla experiência na captação de empréstimos de agências externas.

Dessa forma, o Projeto se destaca por sua relevância, sendo recomendada sua aprovação, assim como a autorização para o seu preparo junto ao agente financeiro escolhido.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ALISSON VILAS BOAS

Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo



Documento assinado eletronicamente por **Alisson Vilas Boas**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 19/09/2024, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45115997** e o código CRC **77EE8C55**.

Referência: Processo nº 03101.002106/2024-83. SEI nº 45115997